



The effectiveness of a counseling program based on the concepts of social learning theory to improve feeding skills in children with autism disorder

Operations

Aya Gharib Mahmoud Ali

PhD Researcher – Faculty of Early Childhood Education, Beni-Suef University

Prof. Adel Abdallah Mohamed

Professor of Mental Health – Faculty of Disability Sciences and Rehabilitation, Zagazig University

Prof. Taha Mohamed Mabrouk

Professor of Child Psychology Faculty of Early Childhood Education - Beni Suef University

Abstract: The current research aims to improve the feeding skills of children with autism as one of the dimensions of self-care skills, through a program based on the concepts of social learning theory. The experimental approach with two groups, experimental and control was relied upon. The sample consisted of (12) children with autism, and they were divided into two equal groups, the first experimental, and the second control, each consisting of (6) children. The following tools were used: a battery of tests for some traditional and digital daily life skills for normal and disabled children and adolescents (prepared by: Adel Abdullah Muhammad, 2025), and the program based on the concepts of social learning theory (prepared by the researcher). The results showed the effectiveness of the program in improving the feeding skills of the experimental group compared to the control group, and in the post-measurement of the experimental group compared to the pre-measurement. It also showed the effectiveness of the guidance program based on the concepts of social learning theory, and this was clear in the follow-up measurement, as there were no statistically significant differences between the post-measurement and follow-up, as well as the continuity of the effectiveness of the program after the end of the follow-up period.

Keywords: Social learning theory concepts – Nutrition skills- Autism disorder.

فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد

إعداد

آية غريب محمود علي

باحثة دكتوراه - كلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة بني سويف

أ.د/ طه محمد مبروك

أستاذ علم نفس الطفل

كلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة بني سويف

أ.د/ عادل عبد الله محمد

استاذ الصحة النفسية - كلية علوم الإعاقة

والتأهيل - جامعة الزقازيق

المستخلص: هدف البحث الحالي إلى تحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد كأحد أبعاد مهارات رعاية الذات، وذلك من خلال برنامج قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي، تم الاعتماد على المنهج التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة، وتكونت العينة من (١٢) طفل من الأطفال ذوي اضطراب التوحد، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين الأولى تجريبية، والثانية ضابطة، قوام كل منهما (٦) أطفال، وتم استخدام الأدوات التالية: بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال والمراهقين العاديين وذوي الإعاقات (إعداد: عادل عبدالله محمد، ٢٠٢٥)، والبرنامج القائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي (إعداد الباحثة)، وأسفرت النتائج عن فعالية البرنامج في تحسين مهارات التغذية لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، وفي القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالقياس القبلي، كما أسفرت أيضًا عن فعالية البرنامج الإرشادي القائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي، وكان ذلك واضحًا في القياس التتبعي حيث أنه لم تكن هناك فروق داله إحصائيًا بين القياسين البعدي والتتبعي، وكذلك استمرارية فعالية البرنامج بعد انتهاء فترة المتابعة.

الكلمات المفتاحية: مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي - مهارات التغذية - اضطراب التوحد.

المقدمة:

يتميز تتعدد وتتنوع الاضطرابات النمائية التي يعيشها الإنسان، منها ما هو بسيط ومعلوم الأسباب وقابل للعلاج ومنها ما يتسم بالغموض والتعقيد سواء في أعراضه، أسبابه، وطرق علاجه، من هذه الاضطرابات الغامضة اضطراب التوحد، والذي أصبح يفرض نفسه بقوة في الآونة الأخيرة مثيرةً معه الكثير والكثير من الفزع والمخاوف سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية أو في بلادنا العربية. ويعد اضطراب التوحد كما تعرفه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الولايات المتحدة الأمريكية (2011) Centers for Disease Control and Prevention بمثابة إعاقة نمائية معقدة تظهر خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، وينتج عنها اضطراب نيورولوجي يؤثر سلبيًا على الأداء الوظيفي للمخ. وتعرفه الجمعية الأمريكية لاضطراب التوحد كما يشير دافيز Davis (2002) على أنه اضطراب عصبي يلزم الفرد طوال حياته، ويؤدي عن ذلك عجز في عملية التعلم بشكل عام وعملية التنشئة الاجتماعية بشكل خاص.

كما يشير عادل عبدالله (2021، 70) بأنه اضطراب نمائي عام منتشر في واقع الأمر شكلاً من أشكال الإعاقة العقلية حيث يتأثر الأداء الوظيفي العقلي للطفل سلبيًا من جرائه، ويكون مستوى الذكاء في حدود الإعاقة العقلية الفكرية البسيطة أو المتوسطة، وهناك شبه إجماع بين الباحثين والعلماء المهتمين بهذا المجال على أن اضطراب التوحد يعتبر إعاقة عقلية معقدة، ومن هذا المنطلق يعتبر إعاقة عقلية واجتماعية في ذات الوقت. فتؤكد دراسات كلاً من (Marzi (2022؛ Joseph & Delariarte (2022؛ Asta & Persico (2022) على ذلك. كما أن هؤلاء الأطفال لديهم قصور في القيام ببعض المهارات الاستقلالية؛ مما يؤدي إلى اعتماد هؤلاء الأطفال على أسرهم في القيام بتلك المهارات؛ فبذلك يصبح الطفل معتمداً على الآخرين، ومن هنا يجب تنمية مهارات رعاية الذات لديهم.

أشار ماجد السيد (2005، 48) أن الطفل ذوي اضطراب التوحد لديه قصور وعجز في العديد من المهارات السلوكية التي يستطيع أدائها الأطفال العاديين من هم في نفس سنه ومستواه الاجتماعي والاقتصادي، ففي عمر خمس أو عشر سنوات لا يستطيع الطفل ذوي اضطراب التوحد أداء أعمال يقوم بها طفل عمره الزمني سنتين أو أقل، كما يعجز عن رعاية نفسه أو حمايتها أو إطعام نفسه بل يحتاج لمن يُطعمه أو يقوم بخلع الملابس وارتدائها، وأسفرت عن ذلك نتائج دراسة عبده سعيد (2014) إلى وجود قصور في مهارات رعاية الذات لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد بشكل عام ومهارات التغذية كأحد أبعاد مهارات رعاية الذات بشكل خاص.

ذكرت سميرة عبد اللطيف (2001، 65) في دراستها أن الطفل ذوي اضطراب التوحد يواجه صعوبة في أداء مهارات التغذية كأحد أبعاد مهارات رعاية الذات، كما تتمثل مهارات التغذية في: استعمال أدوات المائدة، تناول الطعام والشراب، ويحتاج إلى المساعدة في تلك الأمور؛ لهذا يجب تعليمه كيف يعتني بنفسه تدريجياً، حتى يصل إلى مرحلة الاعتماد على نفسه ويعزز شعوره بالاستقلالية.

ومن زاوية أخرى أشار كريم منصور (٢٠١٩، ٧٨) إلى إن اكتساب مهارات التغذية من شأنه أن يخفف العبء الملقى على الأهل ومقدمي الرعاية؛ فهناك حاجة ماسة لتعليم هذه المهارات للأطفال ذوي اضطراب التوحد لحصولهم على استقلاليتهم وزيادة من فرص اعتمادهم على ذاتهم. وأسفرت دراسة سهى بدوي (٢٠١٦) على ضرورة تنمية مهارات التغذية لدى الطفل ذي اضطراب التوحد، كما تؤكد دراسة ريم أحمد (٢٠١٩) على ضرورة تنمية المهارات الاستقلالية لدى الأطفال التوحيديين والعمل على تحسينها.

وتعتبر نظرية التعلم الاجتماعي لبندورا من النظريات التي تقوم على النمذجة والتقليد والمحاكاة وتعلم المهارات والسلوكيات من خلال مشاهدة سلوكيات النموذج الصحيح والتأثر به والتعلم منه مع استخدام التعزيز للسلوك الصحيح، ويمكن القول أن الأطفال ذوي اضطراب التوحد يتأثرون بما يشاهدونه من سلوكيات الآخرين على النحو الذي يتأثر به الأسوياء، لذلك من الضروري أن نركز انتباههم على الأبعاد البارزة من السلوك النمذج (جمال محمد، ٢٠٠٣، ٥٤).

فمن الأهمية إعداد البرامج الإرشادية على استخدام استراتيجيات وأسس ومفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي ومحاولة الكشف عن الآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك في حل المشكلات والمعوقات التي تواجهه، ولأسيما المعوقات المهمة لذوي اضطراب التوحد مثل تحسين مهارات التغذية. ومما سبق يسعى البحث الحالي إلى تقديم برنامج إرشادي قائم على نظرية التعلم الاجتماعي في تحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد .

مشكلة البحث

ظهرت مشكلة البحث الحالي من خلال ملاحظة الباحثة لسلوك الأطفال ذوي اضطراب التوحد أثناء معاشتها لهؤلاء الأطفال في أحد المراكز الاختصاصية - من أجل ثقل مهارتها في كيفية التعامل مع أطفال اضطراب التوحد - في محافظة بني سويف، ووجدت أن هؤلاء الأطفال يظهرون قصوراً في مهارات التغذية؛ حيث يعتمدون بشكل كبير على مقدمي الرعاية لهم في تلبية حاجاتهم الأساسية: من تناول الطعام والشراب، واستعمال أدوات المائدة، والمحافظة على آداب المائدة.

وإضافة إلى ذلك بعض ما توصلت إليه نتائج الدراسات والبحوث السابقة؛ مثل دراسة محمد موسى، زينب شقير، وعادل عبدالله (٢٠٠٦)، Gal (2007)، عواطف الشمري (٢٠٠٨)؛ أسامة عبدالقادر (٢٠٠٩)، أمل علي (٢٠١١)، غادة قطب (٢٠١٢)، إحسان غديفان (٢٠١٦)، عزة جمال (٢٠١٧)، وأشارت النتائج إلى قصور مهارات التغذية كأحد أبعاد مهارات رعاية الذات لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد.

والجدير بالذكر أن مهارات التغذية تمثل ضرورة حتمية لجميع الأطفال ذوي اضطراب التوحد؛ فهي تعتبر من المتطلبات التي يحتاج إليها هؤلاء الأطفال؛ لكي يتوافقوا مع المجتمع الذي يعيشون فيه، وامتلاك هذه المهارات يُعتبر شرطاً أساسياً ومتطلباً ضرورياً لمجتمع اجتماعياً في كافة نواحي الحياة، كما أنها تشكل أساساً لبناء أشكال أخرى من المهارات اللاحقة، كالمهارات قبل الأكاديمية، والمهارات الاجتماعية، وغيرها.

فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد

ولقد تناول ألبرت باندورا Bandura في نظرية التعلم الاجتماعي؛ والذي يرى أن البرامج التدريبية التي تتبع أسلوب النمذجة إنما تعتمد في الأساس على تقديم النماذج التطبيقية، وتعد من الأساليب الفعالة في هذا الصدد، وأن هذه البرامج تعتمد على استخدام وتقديم النماذج المختلفة (حية - رمزية) التي يتم توظيفها جميعاً لتمكين الطفل من استقبال المعلومات بشكل يشعره بأنه في موقف الخبرة ذاته ومعالجته حسيًا بشكل مناسب كما تساعد على التفاعل، ومن جهة أخرى فإن هذه البرامج تساعد في تنمية مهاراتهم، وتفكيرهم مما يساعدهم على تنمية معارفهم، ومعلوماتهم، ومفاهيمهم وذلك بالتفاعل مع المواد المتاحة وهو ما يتطلب ردود أفعال جديدة لكل موقف تعليمي فيؤدي ذلك إلى الإثارة والتقليد، وتحفيز الأطفال على النشاط بشكل مستمر وهو ما يمكن أن يساعدهم على الاحتفاظ بالمعارف والمفاهيم التي تتضمنها الأنشطة المقدمة لهم من خلال البرنامج وذلك لأطول فترة ممكنة (عادل عبدالله، ٢٠٢١، ٥٣).

واستناداً إلى نظرية التعلم الاجتماعي لـ ألبرت باندورا تم تصميم برنامج لتحسين مهارات التغذية للأطفال ذوي اضطراب التوحد، وذلك يكون في سن مبكر حيث أن التدخل المبكر قد ثبتت فعاليته مع هؤلاء الأطفال ويسعى هذا البحث إلى إشراك أولياء الأمور في تطبيق الأنشطة لأبنائهم، مما يساعد في مواجهة القصور والوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تحسين مهارات التغذية وما يترتب عليه من قلة الاعتمادية على الآخرين وزيادة التواصل الاجتماعي وخفض المشكلات السلوكية لدى أطفال ذوي اضطراب التوحد.

ولدراسة هذه المشكلة والإسهام في حلها سوف يتم الإجابة على السؤال الرئيسي التالي:

ما فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى

الأطفال ذوي اضطراب التوحد؟

وسوف يتم الإجابة عنه من خلال عدد من الأسئلة الفرعية التالية:

١- ما الفروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أطفال المجموعة الضابطة

في القياس البعدي على بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال

والمراهقين العاديين وذوي الإعاقات؟

٢- ما الفروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس القبلي ومتوسط درجاتهم في

القياس البعدي على بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال والمراهقين

العاديين وذوي الإعاقات؟

٣- ما الفروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي ومتوسط درجاتهم في

القياس التتبعي على بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال والمراهقين

العاديين وذوي الإعاقات؟

أهداف البحث

تتمثل أهداف البحث في:

- ١- تحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد.
- ٢- التحقق من فعالية البرنامج الإرشادي القائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي في تحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد.
- ٣- التحقق من استمرارية فعالية البرنامج الإرشادي القائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي في تحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد.

أهمية البحث

تتبع أهمية البحث الحالي من أهمية المتغيرات قيد البحث "نظرية التعلم الاجتماعي، مهارات التغذية"، إذ تنقسم أهمية البحث الحالي إلى:

أولاً: الأهمية النظرية:

- ١- زيادة التوجه نحو مداخل التدريب على مهارات التغذية، كمحور أساسي لتدريب الأطفال ذوي اضطراب التوحد.
- ٢- تقديم نماذج للتدريب على نظرية التعلم الاجتماعي، لمساعدة الممارسين على تخطي الفجوة بين النظرية والممارسة في هذا المجال خاصة مع ظهور صيغ جديدة للتربية في العصر الحالي مثل التعلم بالحاكاة أو التعلم المنمذج، ومن ثم فإن هناك ضرورة لتنمية مهارات أساسية مثل مهارات التغذية داخل مؤسساتنا وأنظمتنا التعليمية.
- ٣- أهمية مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي بالنسبة للأطفال ذوي اضطراب التوحد؛ حيث يوفر هذا البحث قدرًا من المعلومات عن أهمية هذه النظرية بالنسبة للأطفال ذوي اضطراب التوحد، ودورها الفعال في تحسين مهارات التغذية.

ثانيًا: الأهمية التطبيقية:

- ١- توجيه الأخصائيين نحو نظريات فعالة، ومن ثم رفع كفاءة العملية التعليمية.
- ٢- تقديم برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي للأطفال ذوي اضطراب التوحد.
- ٣- تقديم دليل لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أطفالهم ذوي اضطراب التوحد، والتعرف على مشكلات مهارات التغذية لديهم.

المصطلحات الإجرائية للبحث

مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي

تعرفها الباحثة بأنها " تلك المفاهيم التي تقوم بإكساب وتعليم وتدريب الأطفال ذوي اضطراب التوحد مهارات التغذية، وذلك عن طريق التقليد والنمذجة والتعزيز".

مهارات التغذية

فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد

تعرفها الباحثة بأنها "هي أحد أبعاد مهارات رعاية الذات التي تساعد الطفل ذوي اضطراب التوحد على إشباع متطلباته وحاجاته الأساسية والمتمثلة في: (مهارات تناول الطعام والشراب، وآداب المائدة، والأطعمة والمشروبات الصحية والغير صحية).

اضطراب التوحد

اتفقت الباحثة مع تعريف عادل عبدالله (٢٠٢١) أن اضطراب التوحد اضطرابًا نمائيًا عصبيًا معقدًا يلزم الفرد مدى حياته، ويمكن النظر إليه من جوانب سته على أنه اضطراب نمائي عام أو منتشر يؤثر سلبيًا على العديد من جوانب نمو الطفل، ويظهر على هيئة استجابات سلوكية قاصرة وسلبية في الغالب تدفع بالطفل بالتوقع حول ذاته، كما يتم النظر إليه أيضًا على أنه إعاقة عقلية، وإعاقة اجتماعية، وعلى أنه إعاقة عقلية اجتماعية متزامنة إي تحدث في ذات الوقت، وكذلك على أنه نمط من أنماط اضطراب طيف التوحد يتسم بالصور في السلوكيات الاجتماعية والتواصل، واللعب الرمزي فضلًا عن وجود سلوكيات واهتمامات نمطية وتكرارية ومقيدة كما أنه يتلازم مرضيًا مع اضطراب قصور الانتباه.

الإطار النظري والدراسات السابقة

المحور الأول: اضطراب التوحد

يعد اضطراب التوحد Autism Disorder من الاضطرابات النمائية العصبية التي تتميز بعجز متواصل في مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي، ومهارات اهتمام محددة (سلوكيات تكرارية ونمطية واهتمامات محددة وتحدد شدته وفقًا إلى مستويات الدعم وتشخيص أعراضه في مرحلة الطفولة المبكرة (من الميلاد إلى سن الثامنة من العمر). اضطراب التوحد يحدث في كافة الثقافات، والعرقيات، والطبقات الاجتماعية والاقتصادية (إبراهيم الزريقات، ٢٠٢٠، ٥٤). التقديرات الحديثة لإنتشار اضطراب التوحد وفقًا للمركز الأمريكي للسيطرة والوقاية من الأمراض Centers of Disease Control and Prevention CDC, 2019 تشير إلى انه يحدث بنسبة 1 لكل 59 طفلًا، كما انه ينتشر بين الذكور أكثر من الإناث (Wright, 2017, 45).

ويرى عادل عبدالله (٢٠٢١، ٧٣) أن الصورة الكلية الشاملة لاضطراب التوحد توضح أن هذا الاضطراب يمكن النظر إليه من زوايا سته حيث يعد اضطرابًا معقدًا يمكن النظر إليه على أنه اضطراب نمائي عام أو منتشر، وعلى أنه إعاقة عقلية، وإعاقة اجتماعية، وعلى أنه إعاقة عقلية اجتماعية متزامنة أي تحدث في ذات الوقت، وكذلك على أنه نمط من أنماط اضطرابات طيف التوحد، وعلى أنه يتلازم مرضيًا مع اضطراب قصور أو تشتت الانتباه.

ومما سبق يتبين أن اضطراب التوحد يعد اضطرابًا معقدًا فيجب النظر إليه نظرة شاملة ودقيقة، تتفق مع طبيعته المعقدة، وضرورة إجراء الكشف المبكر عن اضطراب التوحد في سن مبكرة، بما يتفق مع طبيعته المعقدة وضرورة الكشف والتشخيص المبكر حتي نتمكن من تحديد أساليب مناسبة ودقيقة، وإجراء التدخل العلاجي في وقت مبكر إن أمكن. ومن الأمثلة على بعض العلامات المبكرة: قلة تواصل الطفل بطريقته

الخاصة مع الآخرين، لا ينطق بكلمه في عمر ١٦ شهر، لا يجمع بين كلمتين في عمر سنتين، لا يعرف اسمه عندما ينادي به، التعلق بلعبة أو غرض معين، عدم الابتسام وأحيانًا يبدو وكأنه لا يسمع، تواصل بصري ضعيف، حركات جسدية متكررة في استخدام الأشياء أو الكلام.

مفهوم اضطراب التوحد

اتفقت معظم التعريفات على أن طفل التوحد لديه نزعات انسحابية انطوائية شديدة من البيئة المحيطة به، وينشغل بذاته أكثر من العالم الخارجي، ومن خلال الإطلاع على العديد من تلك التعريفات كتعريفات كلاً من: (علا عبد الباقي (٢٠١١)؛ عادل عبدالله (٢٠١١)؛ National Society for Autistic Children (2012) "NSAC" الجمعية الوطنية للأطفال المتوحدين في أمريكا؛ عادل عبدالله (٢٠١٣)؛ عبدالعزيز الشخص (٢٠١٣)؛ عادل عبدالله (٢٠١٤)؛ مصطفى عصام (٢٠١٥)؛ خالد شريف (٢٠١٥)؛ تم استخلاص التالي:

- اضطراب التوحد أحد الاضطرابات النمائية ويظهر خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، ويجعل الطفل منطويًا ومنسحبًا عن العالم الخارجي مكونًا عالمًا خاصًا به.
- هو عبارة عن المظاهر المرضية الأساسية التي تظهر قبل ان يصل عمر الطفل ٣٠ شهرًا، ويتضمن عدة مظاهر كأضطراب سرعة النمو واضطراب في الاستجابة للمثيرات واضطراب في الكلام واللغة وأيضًا اضطراب في التعارف والانتماء للناس والأحداث والأشياء.
- يحدث اضطراب التوحد نتيجة اضطراب عصبي يؤثر على الطريقة التي من خلالها تتم جمع المعلومات ومعالجتها بواسطة الدماغ.
- كما يؤثر سلبًا على مختلف جوانب النمو وليس جانب واحد، والتي تظهر في النواحي الاجتماعية التواصلية والعقلية والانفعالية والعاطفية، كما يؤثر على مهارات التواصل سواء كان لفظي أو غير لفظي إلى جانب قصور في تعبيرات الطفل الانفعالية مما يتسبب في تدهور شديد في تفاعلاته الاجتماعية.
- يشخص اضطراب التوحد بشكل دقيق بعد بلوغ الطفل ثلاث سنوات، ولكن يمكن ملاحظة بعض العلامات المبكرة قبل بلوغ الثلاث سنوات، مثل عدم الاستجابة لاسمه، عدم التواصل البصري مع الآخرين، العجز في اللعب التخيلي، عدم الاستجابة للتعليمات.

أسباب اضطراب التوحد ونسبة انتشاره

أرجعت أفكار التحليل النفسي على مدى عقود عديدة حدوث اضطرابات التوحد إلى الاتجاهات الوالدية أو سلوك الوالدين. ومع ذلك فنحن نعلم في وقتنا الراهن أن ذلك التفسير الذي قدمه التحليل النفسي لم يكن صوابًا بل كان خطأ حيث يرجع اضطراب التوحد إلى اختلال في الأداء الوظيفي للمخ . كما أننا نعلم إلى جانب ذلك أن أسر هؤلاء الأطفال وخاصة والدوهم قد خبروا قدرًا كبيرًا من الضغوط نظرًا لأنهم فوجئوا بإعاقه طفلهم بشكل أقل ما يقال عنه أنه كان مفاجئًا وغير متوقع. وبالنسبة لهذا الطفل فإنه عادة ما يشبه الأطفال

فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد

العاديين، وغالبًا ما يكون قد مر بفترة قصيرة من النمو الطبيعي تتراوح بين بضع شهور إلى عدة سنوات وذلك قبل أن يلاحظ الوالدان حدوث شيء خاطئ بالنسبة له، وبالتالي فإنهما يشركان في التصرف بأساليب تعكس ما يمران به من ضغوط على أثر ذلك إذ أن هذا الطفل يحتاج إلى مهارات والدية غير تقليدية في سبيل التعامل معه فضلًا عن تلك الخبرة غير العادية أو السيئة التي يكون الوالدان قد مر بها على أثر مثل هذا التغير أو التحول الذي يكون قد انتاب طفلهما (عادل عبدالله، ٢٠١١، ١٩).

وقد شهدت معدلات انتشار اضطراب التوحد زيادة مضطردة في السنوات الماضية فقد بلغ نسبة انتشار اضطراب التوحد طبقًا للدليل التصنيف التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية والعقلية في طبعة الخامسة DSM-V في عام ٢٠١٣ على أنها وصلت إلى ١٪ أي (١ : ١٠٠) من السكان مع تقديرات مماثلة في عينات الأطفال والبالغين. وطبقًا لأحدث تقرير من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ نسبة الأطفال الذين تم تشخيصهم باضطراب التوحد ١٨.٥ لكل ١٠٠٠ طفل أي (١ : ٥٤) من الأطفال في عمر ٨ سنوات (Maenner, et, al. 2020) أما بالنسبة للوطن العربي فلا توجد دراسات دقيقة توضح معدل انتشار هذا الاضطراب في معظم الدول العربية، بل يتم الاعتماد على النسب العالمية لتقدير الأعداد بالمقارنة بالتعداد السكاني لكل بلد. أما فيما يتعلق بأسباب اضطراب التوحد تعددت الدراسات التي حاولت معرفة الأسباب المؤدية إلى هذا الاضطراب، وتشير ماري أليكسا (Alexa, 2018) إلى أن الأسباب المؤدية لاضطراب التوحد لا تزال غير معروفة حتى وقتنا الراهن على الرغم من كم البحوث التي تم إجراؤها لمعرفة أي مناطق تتأثر به، والكيفية التي يظهر بموجبها أولى الإشارات الدالة عليه حتى نتمكن من القيام بالتشخيص والتدخل المبكر وذلك قبل أن تظهر التغيرات السلوكية الأساسية المميزة للاضطراب من جانب الطفل مما يكون من شأنه أن يؤدي إلى حدوث نواتج إيجابية إذ أنه مع زيادة حدة الاضطراب تزداد درجة القصور في المعالجة الحسية واللغة حتى في السن الصغير، وذلك لدى الأطفال ممن يعانون من هذا الاضطراب ولم يتجاوز عمرهم الزمني العام الواحد، ولذلك فقد حاول الباحثون تحديد أي مناطق من المخ تعتبر هي المسؤولة عن المعالجة الحسية للمثيرات حتى يقوموا بتحديد الميكانيزمات الأساسية لاضطراب التوحد، إلا أنهم لم يصلوا إلى نتيجة قاطعة حتى الآن. ويشير مجدي فتحي (٢٠٠٧) في دراسته إلى أن التوحد ليس مرضًا محددًا ذا عرض معين، وليس له تحاليل أو اختبارات تحدد بل مجموعة من الأعراض والتصرفات تختلف حدتها ونوعيتها من طفل لآخر، كما أنها تتفاوت في الطفل نفسه، وتختلف لديه هذه الأعراض بالزيادة أو النقصان، ومع العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت ما زالت أسباب التوحد مجهولة.

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا أن أعداد المصابين باضطراب التوحد في تزايد مستمر، مما يشير إلى الخطر الذي يدهم أطفال العالم أجمع دون تفريق بين لون أو جنس أو عرق، مما يظهر أهمية برامج التدخل المبكر لزيادة فرص التحسن لهؤلاء الأطفال، وهذا ما سعى إليه البحث الحالي من اعداد برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي في تحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد.

تشخيص اضطراب التوحد

يرى عادل عبد الله (٢٠١٩، ١٦) ان اضطراب التوحد شهد تغيرات متعددة في تصنيفه وتشخيصه وتتمثل تلك التغيرات في مرحلة معينة من تلك المراحل التي مرت بها عملية التشخيص والتصنيف في البداية لم يكن هذا الاضطراب معروفاً قبل أن يكتشفه ليو كانر Leo Kanner عام 1943 أثناء دراسته لسلوكيات مجموعة من الأطفال المعاقين فكرياً، ووجد أن ما يصدر من سلوكيات عن أولئك الأطفال يختلف بدرجة كبيرة في جوانب كثيرة منه عما يصدر عن أقرانهم المعاقين فكرياً، وهنا أكد كانر أنهم يمثلون فئة أخرى غير الإعاقة الفكرية بطبيعة الحال. وقد تم بعد ذلك النظر إلى هذا الاضطراب وتشخيصه على أنه نمط من أنماط الفصام الطفولي مع أن الفرق يكون واضح. ويشير رائد خليل (٢٠٠٦، ٤٥) ان تشخيص اضطراب التوحد وغيره من الاضطرابات النمو الشاملة من أكثر العمليات صعوبة وتعقيداً وإن الصعوبة تزداد في المراحل الأولى لوجود اختلافات في الاعراض.

كما يعاني أطفال ذوي اضطراب التوحد من قصور في أداء بعض المهارات الاستقلالية والحياتية، حيث اتفق عثمان لبيب (١٩٩٦)؛ وماجد السيد (٢٠٠٥) على أن الطفل التوحدي لديه قصور وعجز في العديد من الأنماط السلوكية التي يستطيع أداءها الأطفال العاديين من هم في نفس سنه ومستواه الاجتماعي والاقتصادي، ففي سن (٥) أو (١٠) سنوات من عمره قد لا يستطيع الطفل التوحدي أداء أعمال يقوم بها طفل عمره الزمني سنتين أو أقل، كما يعجز عن رعاية نفسه أو حمايتها أو إطعام نفسه بل يحتاج لمن يطعمه أو يقوم بخلع الملابس وارتدائها وقد لا يهتم عند إعطائه لعبة يلعب بها بل يسارع بوضعها في فمه أو الطرق المستمر عليها بيده أو أصابعه وهو في نفس الوقت يعجز عن تفهم أو تقدير الأخطار التي يتعرض لها، وتشيع لدى أطفال التوحد أعراض التبول الليلي ومشكلات الأكل والأرق. ويشير إلهامي عبدالعزيز (١٩٩٩) في دراسته أن الطفل التوحدي من الممكن أن يشرب سوائل كثيرة بطريقة غير منتظمة كما أنه لديه عدم انتظام في الأكل واللبس والنوم، كما يوجد عدم استقرار في وزن الجسم زيادة أو نقصاناً، ويقتصر طعامه على أنواع معينة، كما نجده مستيقظاً بشكل متكرر ليلاً ويصاحب ذلك هز الرأس وإرجاعها بشكل متكرر. وأثبتت نتائج دراسة عثمان لبيب (٢٠١٢)؛ ودراسة حسن مصطفى (٢٠٠١) أن الطفل التوحدي لديه مشكلات في الطعام والتغذية والشراب، كما أن اضطرابات الإخراج شائعة بين الأطفال التوحيدين.

برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي اضطراب التوحد

قد تم تصميم العديد من البرامج التدريبية والعلاجية المقدمة للأطفال ذوي اضطراب التوحد وتأهيلهم، وذلك مثل برنامج TEACCH الذي يعد أحد برامج التدخل التي يتم في الواقع استخدامها؛ لتعليم الأطفال المهارات المختلفة على شكل مرئي ومنظم، وذلك من خلال صور فوتوغرافية أو صور رمزية (عادل عبدالله، ٢٠١٤، ٢٣). أو الشخصية الاعتبارية أفتار، والتي يتم استخدامها في الأساس في سبيل تعليمهم بعض السلوكيات المرغوبة اجتماعياً، وتعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام الكمبيوتر بصفة أصلية، بحيث لا يمكن تقديمها أو استخدامها بدونها (عادل عبدالله، ٢٠١٤، ١٩١). وكذلك التدخل المكثف (برنامج لوفاس) والذي

فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد

يعتبر من أشهر الطرق والتي تعتمد على تدريب الطفل بشكل مكثف (عادل عبدالله، ٢٠١٤، ٢٨١). ويتمثل التدريب بطريقة لوفاس والذي يطرحه البحث الحالي في سبيل تحسين مهارات رعاية الذات، أحد أهم استراتيجيات التدخل المكثف، والذي يعتبر بمثابة طريقة تدريب مكثفة، يتم استخدامها مع الأطفال ذوي اضطراب التوحد، وهدفه الأساسي هو العمل على تحسين مهارات رعاية الذات من خلال برنامج تدريبي مكثف يعتمد على العمل الفردي.

تعقيب على المحور الأول

يعد التوحد اضطراب عصبي يؤثر على تطور الدماغ والتفاعلات الاجتماعية، حيث إنه يعد من أكثر العمليات صعوبة وتعقيداً؛ لأنها تتطلب تعاون فريق من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وذلك لأن أعراض التوحد تظهر بدرجات متفاوتة وأيضاً تتشابه مع اضطرابات نمائية أخرى. كما أنه يعد اضطراب نمائي يظهر عند الطفل خلال الثلاث سنوات الأولى من عمره، ويتميز هذا الاضطراب بالعزلة الاجتماعية، والخلل في التفاعل الاجتماعي، التواصل اللفظي وغير اللفظي، والحركات النمطية المتكررة، والتمسك الشديد بالروتين، كما أن تنوع أعراض اضطراب التوحد والسلوكيات التي تظهر على هؤلاء الأطفال تختلف من طفل توحيدي إلى طفل آخر، وتتمثل في قصور في التفاعل الاجتماعي وسلوك نمطي متكرر وهذه الخصائص أساسية يعتمد عليها في تشخيص التوحد، إلى جانب وجود خلل حسي في إحدى أو جميع الحواس، وصعوبة في التعبير عن المشاعر، وقصور في مهارات اللعب مع أقرانه، كذلك قصور في مهارة التقليد وبالتالي يصاحبها قصور في مهارات رعاية الذات، وبالتالي يوجد لدينا مجموعة من الأعراض التي يمكن للأسرة أن تتعرف من خلالها على حالته كطفل ذوي اضطراب التوحد منذ الشهور الأولى في عمره، فتسهل من عملية الاكتشاف المبكر للحالة، وتتيح الفرصة للتدخل المبكر أيضاً، فقد أشارت دراسة (Biklen 2002) على أن الطفل التوحيدي يمارس أنواع سلوكية نمطية تهر وتختفي بشكل تلقائي وفجائي، وكذلك نتائج دراسة (Wolf 2005) التي أشارت إلى أن السلوك النمطي يتضمن: حركات تلقائية ميكانيكية غير متعمدة، إيذاء النفس بشكل مستمر، الرتابة وعدم احتمال التغيير، ورفرفة اليدين وتحريك الأشياء بشكل كروي دائري.

المحور الثاني: مهارات التغذية

وتتمثل فيما يلي:

أولاً: مهارات تناول الطعام والشراب، وآداب المائدة:

لعل تناول الطعام والشراب من أكثر المشكلات التي تترك الأمهات مع أطفالهم ذوي اضطراب التوحد، حيث يعاني هؤلاء الأطفال من مشكلات عديدة، فتعد مهارات إعداد وتناول الطعام والشراب والمحافظة على آداب المائدة من المهارات الاستقلالية الأساسية، فإن قدرة الطفل على إتقان مهارة إعداد طعامه لوحده وتناوله في نسق سلوك اجتماعي مقبول، هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه عند الطفل التوحيدي، لما له من أهمية كبيرة في عملية استقلال الطفل (فاروق فارغ، وصالح عبدالله، ورويدا محمد، ٢٠١٥). ويوضح عبدالرحمن سيد

(٢٠٠٤) أن عادات الأكل والشرب، وما يفضله الطفل وما لا يفضله تكون غالبًا لها صورة متطرفة، فالأطفال لا يأكلون ولا يشربون إلا أصنافًا محدودة التنوع ويصرون على عدم الأكل أو الشرب إلا باستخدام أطباق وأكواب معينة ومنهم من يظهر تصميمًا على رفض تناول الطعام بطريقة غير مهذبة، وبالتالي يظهرون مظهرًا غير سوى أثناء تناولهم الطعام والشراب بين الناس.

ويضيف ربيع شكري (٢٠٠٥، ٥٦) أنه من المشكلات المتعلقة بذلك مشكلة المزاج المفرط إما الاصرار على تناول طعام معين، وفي بعض الأحيان يصر الطفل على أن يقدم الطعام ويرتب بنفس الطريقة على المائدة دون أي تغيير، وقد يفسر ذلك على أنه شكل من أشكال السلوك الاستحوازي، ومن العوامل التي تساعد الطفل في هذا السلوك خشية الأهل من أن تؤدي محاولة للتغيير في طريقة تقديم أو ترتيب الطعام إلى إصابة الطفل بنوبات الغضب.

وقد أشار Carr & Kemp (2013) في دراسته إلى ضرورة تنمية المهارات المتعلقة بالطعام والشراب لدى الأطفال المصابين باضطراب التوحد، حتى يستطيع الطفل ذوي اضطراب التوحد أن يتوافق مع نفسه ومع الآخرين ونساعده على تحقيق الأهداف والحاجات والمتطلبات الخاصة بالمرحلة العمرية التي ينتمي إليها . ومن ثم يجب الاهتمام بتدريب الأطفال ذوي اضطراب التوحد على إعداد أشياء بسيطة والقيام بمهام صغيرة كعمل السندوتشات أو تقشير البازلاء، ولابد من الاهتمام في كل هذه الأعمال بالنظافة والسلامة كغسل الأيدي قبل تحضير الطعام والحرص عند استخدام أدوات حادة .

ويتم استخدام العديد من الفنيات لتدريب الأطفال على مهارات تناول الطعام والشراب، وهناك العديد من الدراسات التي تناولت التدريب على مهارات تناول الطعام والشراب ومنها دراسة لمياء عبدالحمد (٢٠٠٨) والتي هدفت إلى إعداد برنامج لتنمية بعض مهارات رعاية الذات لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومنها مهارة تناول الطعام والشراب، وأشارت نتائجها إلى فعالية البرنامج التدريبي في اكساب الأطفال ذوي اضطراب التوحد مهارات الرعاية الذاتية.

إجراءات التدريب على مهارة تناول الطعام، وآداب المائدة:

١. يتم تجزئة أو تقسيم الوجبة الصغيرة إلى أجزاء أصغر ، ويتم تقديم كل جزء في كل ساعة أثناء اليوم، حيث توفر هذه الطريقة نوع من الإثارة للتدريب نظرا لان الطفل يكون جائعا بنسبة قليلة وبالتالي تتم المحافظة على الدافعية، ويعنى هذا أن كل جزء من الوجبة الكاملة لا يجب أن يستغرق أكثر من ١٥ دقيقة.

٢. مما ينصح به أن تعقد جلسات التدريب في مكان تناول الطعام من المنزل ، ولكن ليس في أوقات الوجبات المنتظمة حيث تكون هناك المشتتات.

٣. نطلب من الطفل وضع إحدى يديه على حجره ما لم تكن كلتا يديه مطلوبتين لقطع الطعام بالسكين، ويجب ألا تبدأ جلسة التدريب حتى يضع الطفل يده في حجره طواعية أو لا يقاوم تحفظ والديه بشأن اليد التي لا تحمل الملعقة، وهذا الإجراء يقلل فرص القبض على الطعام.

٤. عندما يتم اختيار سلوك الهدف (على سبيل المثال الأكل بالملعقة ممسكا إياها بالأصابع وراحة اليد إلى أعلى) يتم استخدام توجيهه يدوي بطيء وخفيف جدًا للتأكد من أن استجابة محددة أنجزت من قبل الطفل على نحو صحيح، يجب ألا يقوم الوالد بالاستجابة الصحيحة للطفل، ولكي نمنع هذا يجب ألا تكون يد الطفل رخوة في قبضة الوالد، وأيضا ألا يستخدم الوالد قيئًا أو تحفظًا أكثر مما هو ضروري.
٥. يجب أن يبدأ التدريب بأن يقبض الوالد أو المعلم أو مدرب المنزل بيده حول الطفل و يوجهه للاستجابة الكاملة لكي يحقق النجاح في اتجاه سلوك الهدف، عندما يمسك الطفل بنفسه أداة الأكل؛ فإن الوالد يقلل تدريجيا من ضغط يده على يد الطفل، ويقوم بللمسة رقيقة، ومن النجاح المتزايد يتحول التوجيه والضغط من اليد إلى الساعد، عندما يتم المحافظة على النجاح عن طريق الللمسة الخفيفة على الساعد، ويتقدم الوالد بيده ويطبقها على كتف الطفل ثم على أعلى الظهر، ويتم الإبقاء على لمسة رقيقة ما لم يكن مطلوبًا المزيد من التوجيه.
٦. يتم تقديم كل أداة من أدوات الأكل على نحو منفصل في جلسة التدريب، ويجب تقديم نوع واحد من الطعام بحيث يكون مناسبًا للأداة الموضوعية بعد تقديم كل أداة بصفة مستقلة، ويتمكن الطفل منها، وبالتالي يمكن تقديم مجموعات مختلفة من الطعام تتطلب أكثر من أداة واحدة مثل المناديل والسكاكين والشوك .
٧. يتم إعطاء الطفل قدرًا كبيرًا من التعزيز المعنوي مقابل جهوده الأولية في الإمساك بالأداة وملئها بالطعام في سياق الأكل، وربما يقول الوالد أو المعلم للطفل " حسنا " عندما يلتقط الأداة أو عندما ينقلها إلى الطبق وهكذا.
٨. يجب أن يتحدث الوالد أو المعلم مع الطفل على نحو مشجع، وبصفة مستمرة طوال جلسة التدريب، وينقل إليه ما يدور حوله بلطف، وكما يمتدح بإخلاص كل جهد صادق يبذله الطفل نحو إنجاز استجابة الأكل المستقلة، ويضمن هذا أن جلسة التدريب سوف تكون معززة إيجابيًا وذات مغزى بالنسبة للطفل.
٩. يجب تقديم تشكيلة من المعززات وعدم الاعتماد على معزز لفظي واحد، كما أن المدح اللفظي يجب أن يكون سارًا، واللمس أيضا يمكن أن يكون معززًا قويًا، وكذلك معانقة الطفل عندما يؤدي أداءً حسنًا، واستخدام تعبيرات الوجه الدالة على الاستحسان، خاصة إذا كان الطفل ضعيف السمع.
١٠. عندما لا يتبع الطفل التعليمات على نحو ملائم أو يُبدى بعض المقاومة يتم استخدام توجيهه اليدوي، وكما وصف من قبل لتقديم الاستجابة الملائمة، كما يجب تجنب الإساءة اللفظية أو المضايقة نظرًا لأنها تركز الانتباه على السلوكيات المقاومة وغير الملائمة.
١١. يتم إيقاف الطفل بصورة بدنية عند ارتكاب الأخطاء الواضحة في جلسة التدريب على سبيل المثال؛ عندما يحاول وضع الطعام في فمه بدون أداة تناول الطعام لأن السماح له للقيام بذلك يعوق اتساق

وثبات التدريب، ويسبب اضطراب الطفل، والتباس الأمر عليه بحيث لا يستطيع تمييز ما هي الاستجابات الصحيحة.

١٢. عندما يحدث خطأ ما يجب أن يتم تدريب الطفل على الاستجابة الصحيحة بعد عمل التصحيح، وسوف يعرف الطفل الاستجابة الصحيحة أثناء الوجبات اللاحقة.

١٣. يجب أن يتقدم التحسن التدريجى فى معايير تناول الطعام؛ فعندما يستطيع الطفل مسك وملء الأداة فى التدريب المبكر يجب أن يصل الطعام إلى فمه "مباشرة" بغض النظر عن تساقط القليل منه عند هذه النقطة.

١٤. ما دام الطفل قد تمكن من استخدام الأداة فإنه سوف يتعلم تجنب سكب الطعام أو إسقاطه لاضطراره إلى تنظيف موضع سقوط الطعام بنفسه، وعندئذ يجب على الوالد أو المعلم عدم تصحيح الأخطاء أو تنظيف تلك المواضع بعد تلك الأحداث المؤسفة.

١٥. يجب أن يستمر التدريب حتى يصبح التعلم كاملاً وثابتاً، وعندما يبدأ التدريب يجب أن يكون أحد الوالدين موجوداً فى كل وجبة لأن أخطاء الطفل فى تناول الطعام تثبت، وترسخ بدون إشراف.

١٦. يجب أن يكون التدريب متسقاً بين كل وجبة، وهذا يعنى أن كل الطعام الضرورى للتدريب يجب أن يكون متاحاً؛ فإذا كان الطفل تعلم تناول الأطعمة بالأصابع على سبيل المثال، حينئذ يجب أن تتوفر تلك الأطعمة فى كل وجبة (إيرلى بالنازار، ١٩٩٩؛ رونالدكوروسو، كولين أورورك، ٢٠٠٣؛ سوسن شاكر، ٢٠٠٥).

إجراءات التدريب على مهارة الشرب:

١. يتم تقديم السوائل فى كأس أو كوب بطريقة مثيرة تشجع الطفل على التدريب، وهنا يستطيع الوالد أو المعلم أو المدرب أن يحمل الكأس أو الكوب للطفل.

٢. ينصح أن يكون تناول السوائل فى أوقات مناسبة على سبيل المثال (بعد الوجبات) حتى يستجيب الطفل للتدريب.

٣. نطلب من الطفل أن يحمل الكأس بيديه، وأن ييلع السائل بطريقة ملائمة.

٤. يتم استخدام التوجيه اللفظى للطفل حيث نوجهه بأن لا يقطر السائل أو يسيل لعابه أثناء الشرب.

٥. نطلب من الطفل الاحتفاظ بالسائل فى وضع عمودى حيث يحتفظ الطفل بالسائل فى فمه أثناء الشرب من الكأس أو الكوب فى وضع الجلوس.

٦. يتم ملاسة الطفل للكأس عند الشرب بيد واحدة أو بكلتا يديه.

٧. عندما نجد مقاومة من الطفل وعدم إتباعه للتعليمات يتم استخدام التوجيه اليدوى وذلك لتقديم الاستجابة الملائمة، كما يجب تجنب الإساءة اللفظية والمضايقة.

فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد

٨. تدريب الطفل على الشرب من الكأس أو العصائر بالشفطة بدون مساعدة حيث يتعامل الطفل مع الكأس والشفطة بنفسه باستخدام إحدى يديه أو كليهما ويرفع الكأس من على المنضدة بنفسه مع استخدام بعض التوجيهات اليدوية له حتى يصل إلى الهدف.
٩. يتم إعطاء الطفل قدرًا كبيرًا من التعزيز اللفظي والاجتماعي على مجهوداته الأولية وتشجيعه بصفة مستمرة طوال جلسة التدريب.

١٠. نطلب من الطفل عدم انسكاب أى سائل أثناء الشرب من الكأس أو أثناء شطف العصائر بعيدا عن المنضدة وعدم انسكاب أى شيء من الكأس أثناء رفعة من على المنضدة حيث ينقل الطفل الكوب أو الكأس مستخدما كلتا يديه دون أن يفقد أى سائل قبل أن يصل إلى فمه، وكذلك توجيهه أن يتبع هذا أيضا عند إعادة الكأس إلى المنضدة (إيرلي بالتازار، ١٩٩٩؛ رونالدكو روسو، كولين أورورك، ٢٠٠٣؛ سوسن شاكر، ٢٠٠٥).

تعقيب على المحور الثاني

وبناءً على ما سبق أتضح لنا أن مهارات التغذية أحد أبعاد مهارات رعاية الذات التي تعد من المهارات الاستقلالية الهامة، والتي يجب تميمتها لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد، لكي يستطيعوا الاعتماد على ذواتهم في (تناول الطعام والشراب، واستعمال أدوات المائدة، والمحافظة على آداب المائدة، والتمييز بين الأطعمة الصحية والأطعمة الغير صحية)؛ وبذلك يصبحوا أشخاص مستقلين بذواتهم مثل الأطفال الأسوياء، وقد أوضحت دراسة إحسان غديفان (٢٠١٦) على ضرورة تنمية المهارات الاستقلالية لدى الأطفال التوحديين، وأيضًا تؤكد دراسة كلاً من إيمان عبيد (٢٠١٦)؛ وريم إبراهيم (٢٠١٥) إلى ضرورة تنمية مهارات رعاية الذات لدى الأطفال التوحديين، وأشارت دراسة صابرة عبدالناصر (٢٠٢٢) على ضرورة التوعية باضطراب التوحد والتدخل المبكر للوقاية من تضاعف الأعراض، ومن هنا يجب استخدام البرامج لتعليم أطفال الروضة ذوي اضطراب التوحد المهارات الاستقلالية ومن ضمنها مهارات رعاية الذات، كما أوضحت دراسة كوثر عبدربه (٢٠١٢) على ضرورة تنمية مهارات الحياة اليومية لدى الطفل التوحدي باستخدام برنامج التدخل المبكر.

المحور الثالث: مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي

تقوم هذه النظرية على ثلاثة مفاهيم رئيسية وهي:

- ١- إمكانية السلوك: يعرف روتر مفهوم إمكانية السلوك بصورة علمية على أنه " القدرة الكامنة لأي سلوك يحدث في أي موقف من المواقف أو في أكثر من موقف كما هو محسوب بالنسبة لأي شكل أو مجموعة من أشكال التعزيز"، وهذا المفهوم النسبي يشير إلى احتمال قيام الإنسان بالاستجابة- بطريقة ما- مقرونة بأنماط السلوك البديلة وأنماط السلوك متعددة لا حصر لها، تتراوح بين الابتسامة إلى السب، ومن الكبت إلى الإسقاط، ومن التفكير إلى التخطيط (جورج وآخرون، ١٩٨٦، ٢١٠).

٢- مفهوم التوقع: وهو نوع من الاحتمال الذاتي يعني أن الاحتمال لا يتحدد بصورة أكيدة مضمونة وإنما يتأثر بعدة عوامل مثل طريقة الناس في تصنيف الأحداث أو تعميم النتائج السابقة وتحديد الأسباب، وقد عرف روتر التوقع بأنه "الاحتمال الذي يضعه إنسان ما لأحداث السلوك المحدد الذي سيقوم به موقف معين أو في مواقف معينة" (أنور الشرقاوي، ١٩٨٦، ١٢٣).

٣- قيمة التعزيز أو التدعيم: وقيمة التعزيز تعبير نسبي يشير إلى أن الإنسان يفضل شيئاً ما على آخر، ويرى روتر أن قيمة التعزيز هي درجة تفضيل المرء ورغبته في الحصول على تقدير ما (جورج وآخرون، ١٩٨٦، ٢١٠).

شروط ضرورية لحدوث التعلم الاجتماعي (بالملاحظة):

- ١- أن يدرك الملاحظ سلوك النموذج، فلن يقلد الملاحظ سلوكاً لا يراه أو يسمعه.
- ٢- أن يكون الملاحظ قادراً على أداء سلوك النموذج، وأن يكون مهتماً بالتقليد.
- ٣- أن يتوفر نموذج يتصف بخصائص معينة.
- ٤- أن يرى الملاحظ أن سلوك النموذج يعزز (جودت عبد الهادي، ٢٠٠٧، ٢٦٠).

نواتج نظرية التعلم الاجتماعي (النمذجة):

أولاً: تعلم أنماط سلوكية جديدة:

إن التعرض إلى سلوك النماذج وعمليات التفاعل مع الآخرين ينتج عنها تعلم أنماط سلوكية متعددة مثل المهارات والعادات والممارسات والألفاظ التي ليست في حصيلة الفرد السلوكية. وتزداد احتمالية حدوث هذا النوع من التعلم بزيادة فرص التفاعل مع الآخرين وتنوعها.

ثانياً: كف أو تحرير السلوك:

إن ملاحظة سلوك الآخرين وما يترتب عليه من نتائج ربما تعمل على كف أو تحرير سلوك لدى الأفراد، فملاحظة نموذج يعاقب على سلوك ما ربما يشكل دافعاً للآخرين للتوقف عن ممارسة مثل هذا السلوك أو كفه، في حين أن مشاهدة نماذج تعزز سلوك ما قد تثير الدافعية للآخرين لممارسة مثل هذا السلوك.

ثالثاً: تسهيل ظهور سلوك:

إن ملاحظة سلوك النماذج ربما تعمل على إثارة وتسهيل ظهور سلوك متعلم على نحو سابق لدى الأفراد لكنهم لا يستخدمونه بسبب النسيان أو أسباب أخرى، فعند ملاحظة نماذج تمارس مثل هذا السلوك ربما يسهل عملية عودته من جديد (حسين أبو رياش، وزهرية عبدالحق، ٢٠٠٧، ٢٧٢).

تعقيب على المحور الثالث

تعتبر الميزة الكبرى للتعلم بالنمذجة على غيره من أشكال التعلم هي أنه يقدم للمتعلم سيناريو تتوالى فيه أنواع السلوك المطلوبة، حيث أنه لن يوضع أمام الطفل ملعقة وطبق وأرز ويطلب منه أن يمسك الملعقة بطريقة صحيحة ويأكل، بل يتعلم عن طريق ملاحظة النموذج ويقوم بتقليده، كما أن نظرية التعلم الاجتماعي تلح على أهمية التعزيز في اتباع عملية التدريب على السلوك المرغوب.

فروض البحث

١- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية ومتوسطي رتب درجات أطفال المجموعة الضابطة في القياس البعدي على بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال والمراهقين العاديين وذوي الإعاقات لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد لصالح المجموعة التجريبية.

٢- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال والمراهقين العاديين وذوي الإعاقات لصالح القياس البعدي.

٣- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي ومتوسط درجاتهم في القياس التتبعي على بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال والمراهقين العاديين وذوي الإعاقات بعد انتهاء فترة المتابعة.

منهج البحث

اعتمد البحث الحالي على المنهج التجريبي، وذلك للتحقق من الهدف الرئيسي للبحث وهو تحسين مهارات التغذية (كمتغير تابع) لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد من خلال مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي (كمتغير مستقل) ويعتمد البحث على التصميم التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة.

عينة البحث

تتكون عينة البحث الحالي من (١٢) طفلاً من الأطفال ذوي اضطراب التوحد وتتراوح أعمارهم من (٤ - ٦) سنوات، قسمت إلى مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة، حيث بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية (٦) أطفال، وعدد أفراد المجموعة الضابطة (٦) أطفال من الأطفال ذوي اضطراب التوحد، تم اختيارهم من مركز ثقة لذوي الاحتياجات الخاصة - بمحافظة بني سويف.

أدوات البحث

(١) بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال والمراهقين العاديين وذوي الإعاقات (إعداد/ عادل عبدالله محمد، ٢٠٢٥)

تهدف هذه البطارية إلى قياس وتقييم إحدى عشرة مهارة من مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية لدى الأطفال والمراهقين العاديين وأقرانهم ذوي الإعاقات، وما تتضمنه كل منها من مكونات أو مهارات فرعية حتى يتسنى لنا الوقوف على مستوى الطفل أو المراهق في كل مهارة منها كي نتخذ القرار المناسب حيالها سواء بإكسابه إياها، أو تحسين مستواه فيها، أو تمييزها أو تنمية أي مكونات تتضمنها، أو مساعدته على تطبيقها وظيفيًا في السياقات الواقعية المختلفة.

وتتمثل هذه المهارات في المهارات التقليدية والرقمية التالية:

١. مهارات الحياة اليومية الشخصية.
٢. مهارات الرعاية الصحية الشخصية.
٣. مهارات التغذية.
٤. مهارات الأمان.
٥. المهارات المنزلية.
٦. مهارات المطبخ.
٧. مهارات غسيل الملابس.
٨. مهارات إدارة النقود والتعامل معها.
٩. المهارات الاجتماعية.
١٠. المهارات المجتمعية.
١١. مهارات الحياة اليومية الرقمية.

الخصائص السيكومترية لمهارات البطارية

لحساب لخصائص السيكومترية للمهارات المتضمنة في بطارية الاختبارات الراهنة تم تطبيق البطارية على عينة (ن=٧٢٠) طفلاً ومراهقاً بواقع ٣٠٠ طفل ومراهق من العاديين بمحافظة الشرقية، ٤٨٠ طفلاً ومراهقاً من أقرانهم ذوي الإعاقات (العقلية - اضطراب التوحد - صعوبات التعلم - السمعية) وذلك من عدة محافظات ضمت الشرقية، والغربية، والاسكندرية، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، وبني سويف، والبحر الأحمر. أولاً: الاتساق الداخلي:

تم حساب الاتساق الداخلي لمهارات التغذية بطريقتين تمثلت الأولى في حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمهارة، وتمثلت الثانية في حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمهارة مطروحاً منها درجة تلك العبارة.

جدول (١)

المهارة	م	١	٢	م	١	٢	م	١	٢
مهارات التغذية	١	٠,٧٢	٠,٦٩	١٣	٠,٧٣	٠,٦٩	٢٥	٠,٧٠	٠,٦٥
	٢	٠,٦٩	٠,٦٥	١٤	٠,٧٥	٠,٧٢	٢٦	٠,٧٤	٠,٧١
	٣	٠,٧٠	٠,٦٧	١٥	٠,٧٠	٠,٦٦	٢٧	٠,٧٨	٠,٧٥
	٤	٠,٧٥	٠,٧١	١٦	٠,٧٦	٠,٧٢	٢٨	٠,٧٣	٠,٧٠
	٥	٠,٦٩	٠,٦٦	١٧	٠,٨٤	٠,٨١	٢٩	٠,٧٧	٠,٧٤
	٦	٠,٦٦	٠,٦٢	١٨	٠,٨١	٠,٧٨	٣٠	٠,٨٠	٠,٧٦
	٧	٠,٧٧	٠,٧٣	١٩	٠,٧٦	٠,٧١	٣١	٠,٧٧	٠,٧٣
	٨	٠,٧٠	٠,٦٥	٢٠	٠,٧٠	٠,٦٧	٣٢	٠,٨٣	٠,٧٩
	٩	٠,٧٤	٠,٧١	٢١	٠,٧٨	٠,٧٥	٣٣	٠,٨١	٠,٧٨
	١٠	٠,٦٨	٠,٦٤	٢٢	٠,٧٢	٠,٦٨	٣٤	٠,٧٢	٠,٧٠
	١١	٠,٨٥	٠,٨١	٢٣	٠,٨٥	٠,٨٢	٣٥	٠,٦٩	٠,٦٥
	١٢	٠,٧٧	٠,٧٣	٢٤	٠,٧٤	٠,٧٠			

ثانياً: إعادة حساب ثبات البطارية بالبحث الحالي:

فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد

تم تقدير ثبات البطارية بالبحث الحالي من خلال طريقة إعادة التطبيق، ومعامل ألفا- كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية، والاعتماد على معامل سبيرمان- براون في حال تساوي نصفي الاختبار، ومعامل جوتمان في حال تساوي النصفين، وذلك على النحو التالي:

جدول (٢) ثبات إعادة التطبيق، ومعامل ألفا، وطريقة التجزئة النصفية (سبيرمان، جوتمان)

الأبعاد	إعادة التطبيق	معامل ألفا	التجزئة النصفية	
			سبيرمان	جوتمان
مهارات التغذية	٠,٧٦٧	٠,٧٨٤	٠,٩٣٩	٠,٧٦٦
دالة عند (٠,٠١)				

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معاملات الثبات مرتفعة ومقبولة إحصائياً، حيث أظهرت معاملات الثبات بطريقة إعادة التطبيق معاملات ثبات مرتفعة للبطارية وكانت داله عند مستوى دلالة (٠,٠١)، وتعد درجة ثبات مرتفعة، وكذلك قيمة ألفا- كرونباخ أن معاملات الثبات مرتفعة، مما تعطي مؤشراً جيداً لثبات بطارية مهارات الحياة اليومية، وبناءً عليه يمكن العمل بها. أما بالنسبة لطريقة التجزئة النصفية فكانت قيمة معامل سبيرمان - براون، ومعامل جوتمان العامة للتجزئة النصفية مرتفعة، حيث تدل على أن بطارية مهارات الحياة اليومية تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

(٢) البرنامج القائم على نظرية التعلم الاجتماعي (إعداد الباحثة)

الهدف العام من البرنامج

يتمثل الهدف العام من البرنامج في تحسين التغذية كأحد أبعاد مهارات رعاية الذات، والحد من الاعتمادية، والتي تهدف أساساً إلى تنمية مهارات الحياة اليومية للأطفال ذوي اضطراب التوحد، ولقد اعتمد البرنامج على نظرية التعلم الاجتماعي لألبرت باندورا، وبعض الفنيات مثل التعزيز، والنمذجة، وتحليل المهمة، وتحفيز الأطفال على التفاعل بشكل مستمر.

الأهداف الإجرائية

يسعى البرنامج من خلال جلساته إلى تحقيق عدد من الأهداف الإجرائية؛ بحيث يصبح الطفل قادراً على أن:

- يشارك الباحثة أثناء الجلسة.
- يتعرف على كيفية الشرب من الكوب دون إراقه.
- يمسك الملعقة بقبضة يد واحدة.
- يأكل بالملعقة بطريقة صحيحة.
- يمسك السكينة ويستخدمها في التقطيع بطريقة صحيحة.
- يتعرف على كيفية تناول الطعام باستخدام الشوكة.
- يصنع ساندويتش بمفرده.

- يميز بين الأطعمة الصحية والغير صحية.
- يحافظ على آداب المائدة.
- يصنف أدوات المائدة.
- يشعر بالسعادة أثناء تطبيق النشاط.

مدة البرنامج:

يتكون البرنامج التدريبي القائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد من (٣٠) جلسة، تم تطبيقهم بمعدل أسبوعين، بواقع (٣) جلسات يوميًا، خمس أيام أسبوعيًا، أي ١٥ جلسة أسبوعيًا، حيث تتراوح مدة كل نشاط ما بين ٢٥ دقيقة إلى ٦٠ دقيقة، كما تم التطبيق بشكل فردي، ومحاولة حث الطفل على المشاركة والتفاعل أثناء الجلسات.

الوسائل التعليمية المستخدمة:

تنوعت الوسائل وفقًا لما تهدف له كل جلسة بالبرنامج، فتم استخدام عدة أنواع من الوسائل والأدوات التعليمية؛ مثل:

- وسائل لفظية: وتتمثل في شرح خطوات الموضوعات المقدمة، ومناقشتها مع الأطفال.
- وسائل سمعية بصرية: وتتضمن عرض صور، وفيديوهات لمحتوى الجلسات.
- وسائل حسية بصرية: وتتمثل في بعض الأدوات؛ مثل (كتاب تفاعلي، بطاقات ملونة، لعبة الفواكة، لعبة صنع السامدويتش، الدمية بوجي، بازل، بطاقات).

أساليب التقييم لجلسات البرنامج:

تم تقييم كل جلسة من جلسات البرنامج من خلال استخدام (أسئلة تُطرح على الطفل حول مضمون الجلسة أو استخدام بطاقات مصورة، أو استخدام البازل)؛ وذلك للتأكيد على مدى استيعاب الأطفال لمضمون وهدف كل جلسة من جلسات البرنامج.

أساليب تقويم البرنامج:

١. التقييم القبلي: يهدف إلى التعرف على مستوى مهارات التغذية لدى الأطفال أفراد العينة.
٢. التقييم المستمر: الذي يتم منذ بداية البرنامج على الأطفال من أجل التأكد من إتقان الطفل لهذه المهارة.
٣. التقييم البعدي: يتم إجرائه بعد انتهاء تطبيق البرنامج، وذلك لمعرفة مدى التقدم الذي حققه أفراد العينة بعد تطبيق جلسات البرنامج.
٤. تقويم تنبئي: يتم بعد انتهاء تطبيق البرنامج، وذلك لمعرفة مدى استمرارية الأثر الذي حققه البرنامج في اكتساب مهارات التغذية لدى أفراد العينة مع مرور الوقت.

إجراءات البحث

- ١- الإطلاع على الأدبيات والدراسات العربية والأجنبية ذات العلاقة بموضوع البحث الحالي.

فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد

- ٢- إعداد برنامج إرشادي قائم على نظرية التعلم الاجتماعي.
- ٣- اختيار عينة البحث وتقسيمها إلى مجموعتين (تجريبية - ضابطة).
- ٤- تطبيق بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية على أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة.
- ٥- تطبيق البرنامج الإرشادي القائم على نظرية التعلم الاجتماعي على أطفال المجموعة التجريبية.
- ٦- تجميع ورصد البيانات ومعالجتها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة والكشف عن نتائجها.

مناقشة النتائج وتفسيرها.

- ٧- تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث.

وفيما يلي عرض لنتائج فروض البحث وتفسيرها:

نتائج الفرض الأول:

ينص على أنه "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية ومتوسطي رتب درجات أطفال المجموعة الضابطة في القياس البعدي على بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال والمراهقين العاديين وذوي الإعاقات لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد لصالح المجموعة التجريبية". ولاختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتني، ويوضح الجدول (٣) نتائج هذا الفرض:

جدول (٣) اختبار مان ويتني وقيمة z ودلالاتها للفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين

التجريبية والضابطة في بطارية مهارات الحياة اليومية (ن = ٢ = ٦)

المهارات	المجموعة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة z	مستوى الدلالة
مهارات	التجريبية	٥٦,٠٠	٢,٩٧	٩,٥٠	٥٧,٠٠	٢,٨٩٢	٠,٠١
التغذية	الضابطة	٤٢,٦٧	٣,٢٠	٣,٥٠	٢١,٠٠		

يتضح من الجدول (٣) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (٠.٠١) بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس لأبعاد مهارات التغذية ببطارية مهارات الحياة اليومية لصالح متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية، أي أن متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية لبطارية مهارات الحياة اليومية أكبر بدلالة إحصائية من نظيره بالمجموعة الضابطة، وهذا يحقق صحة الفرض الأول.

نتائج الفرض الثاني:

ينص الفرض على أنه "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال والمراهقين العاديين وذوي الإعاقات لصالح القياس البعدي". ولاختبار صحة هذا الفرض تم استخدام ويلكوكسون "w" ويوضح الجدول رقم (٤) نتائج هذا الفرض.

جدول (٤) اختبار ويلكوكسون وقيمة Z ودالاتها للفرق بين متوسطى رتب درجات القياسيين

القبلي والبعدى لدى المجموعة التجريبية على بطارية مهارات الحياة اليومية (ن = ٦)

المهارة	القياس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	اتجاه الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	الدلالة	N2	التأثير
مهارات التغذية	القبلي	٤٢,٥٠	٣,٣٣	سالب	صفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٠٧	٠,٠١	٩,٠١	قوي
	البعدى	٥٦,٠٠	٢,٩٧	موجب يساوي	٦ صفر	٣,٥٠	٢١,٠٠				

يتضح من الجدول (٤) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (٠.٠١) بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدى لأبعاد بطارية مهارات الحياة اليومية لصالح متوسط رتب درجات القياس البعدى، أي أن متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدى في الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية لبطارية مهارات الحياة اليومية أكبر بدلالة إحصائية من نظيره بالقياس القبلي وهذا يحقق صحة الفرض الثاني.

نتائج الفرض الثالث:

ينص الفرض على أنه " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدى ومتوسط درجاتهم في القياس التتبعي على بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال والمراهقين العاديين وذوي الإعاقات بعد انتهاء فترة المتابعة " ولاختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون " W " والجدول (٥) يوضح نتائج هذا الفرض.

جدول (٥) اختبار ويلكوكسون وقيمة Z ودالاتها للفرق بين متوسطى رتب درجات القياسيين البعدى

والتتبعي لدى المجموعة التجريبية على بطارية مهارات الحياة اليومية (ن = ٦)

الأبعاد	القياس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	اتجاه الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	الدلالة
مهارات التغذية	البعدى	٥٦,٠٠	٢,٩٧	سالب	٣	٣,١٧	٩,٥٠	٠,٢١٠	٠,٨٣٣
	التتبعي	٥٦,٣٣	٢,٥٠	موجب يساوي	٣ صفر	٣,٨٣	١١,٥٠		غير دالة

يتضح من الجدول (٥) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدى والتتبعي على بطارية مهارات الحياة اليومية، أي أنه يوجد تقارب بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في لقياسين البعدى والتتبعي على بطارية مهارات الحياة اليومية للأطفال ذوي اضطراب التوحد، وهذا يحقق صحة الفرض الثالث.

مناقشة وتفسير النتائج:

أشارت نتائج البحث الحالي على أن مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لها أثر واضح في تحسين مهارات التغذية كأحد أبعاد مهارات رعاية الذات لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد، وكان ذلك واضحاً في نتائج الفرض الأول؛ حيث كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠١) بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك الفرض الثاني حيث كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠١) بين القياسين القبلي والبعدى لصالح القياس البعدى، وكذلك وضحت فعالية مفاهيم

فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد

نظرية التعلم الاجتماعي من الفرض الثالث حيث أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين البعدي والتتبعي في بطارية مهارات الحياة اليومية، وتفسر الباحثة تحسين مهارات التغذية عند أطفال المجموعة التجريبية بنيت على برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي كما تم التطبيق بشكل فردي مما أثبت من فعالية البرنامج الإرشادي في تحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد، واستمرار فعاليته إلى ما بعد انتهاء فترة المتابعة. فقد تم التركيز في البرنامج على الأهداف التي صاغتها الباحثة خلال الجلسات، والمرتبطة بشكل مباشر بتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد، مما أظهر فعالية وأهمية نظرية التعلم الاجتماعي كعلاج لأطفال ذوي اضطراب التوحد.

حيث تتفق نتيجة الفرض الأول مع نتائج دراسة كلاً من ثناء محمد (٢٠١١)، ودراسة ريم إبراهيم (٢٠١٥)، ودراسة غادة قطب (٢٠١٧)، ودراسة علا محمد (٢٠١٨)، التي أكدت على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية ومتوسطي رتب درجات أطفال المجموعة الضابطة على بطارية اختبارات بعض مهارات الحياة اليومية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد لصالح المجموعة التجريبية، كما توصل البحث الحالي إلى أنه بالإمكان تحسين مهارات رعاية الذات بأبعادها المختلفة لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد عن طريق تطبيق البرنامج التدريبي القائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي الذي تم إعداده لهذا الغرض، كما تم التأكيد على أن المجموعة الضابطة لم تخضع للبرنامج الراهن في البحث الحالي، حيث خضعت له المجموعة التجريبية فقط.

وتتفق نتيجة الفرض الثاني مع نتائج بعض الدراسات التي أشارت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد لصالح القياس البعدي، ومنها دراسة مشيرة علي الدين (٢٠٠٩)، ودراسة محمد إبراهيم (٢٠١٣)، ودراسة (عبد سعيد (٢٠١٤)، ودراسة ريم إبراهيم (٢٠١٥)، ودراسة غادة قطب (٢٠١٧)، ودراسة سمر محمود (٢٠١٧). ويمكن للباحثة أن تفسر هذه النتيجة نظراً لتعرض أطفال المجموعة التجريبية للبرنامج الإرشادي القائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي، كما إن هذه النتائج تؤكد في الوقت ذاته على فعالية البرنامج الإرشادي القائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي المستخدم، حيث أنه قد حدث تغيير إيجابي في مهارات رعاية الذات بأبعادها المختلفة للمجموعة التجريبية التي تم تطبيق البرنامج على عينتها من الأطفال ذوي اضطراب التوحد، ومن ثم يرجع التغيير إلى فعالية البرنامج الإرشادي القائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي المستخدم في البحث الحالي.

كما تتفق نتيجة الفرض الثالث مع نتائج بعض من الدراسات التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على بطارية مهارات الحياة اليومية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد، ومنها دراسة مشيرة علي الدين (٢٠٠٩)، ودراسة محمد إبراهيم (٢٠١٣)، ودراسة ريم إبراهيم (٢٠١٥)، ودراسة غادة قطب (٢٠١٧)، ودراسة علا محمد

(٢٠١٨)، وتبين الباحثة إن هذه النتيجة تشير إلى مدى استمرارية تأثير البرنامج الإرشادي القائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي إلى ما بعد انتهاء مدة المتابعة.

توصيات البحث:

في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن تقديم مجموعة من التوصيات للمعلمين والأخصائيين والباحثين وأولياء أمور الأطفال ذوي اضطراب التوحد، ويمكن الاستفادة منها في رعاية الطفل ذو اضطراب التوحد وتحسين مستواه، كالتالي:

- ١) الاهتمام بتدريب الأطفال ذوي اضطراب التوحد على استراتيجيات وأبعاد نظرية التعلم الاجتماعي في تنمية مهارات التغذية، وذلك من خلال دورات تدريبية وإرشادية تحت إشراف المختصين.
- ٢) ضرورة تدريب الاخصائيين وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية على استراتيجيات وأبعاد نظرية التعلم الاجتماعي وتبصيرهم بأهميتها وتعليمهم كيفية تدريب الأطفال ذوي اضطراب التوحد عليها واستخدامها في المواقف الحياتية المختلفة.
- ٣) الاهتمام بتدريب الأطفال ذوي اضطراب التوحد على مهارات التغذية بصورة استقلالية، والتدريب عليها واستخدامها في مواقف الحياة المختلفة.

الدراسات والبحوث المقترحة:

في ضوء ما تم عرضه في البحث الحالي من الإطار النظري وتحليل للدراسات السابقة ذات الصلة، وما أسفر عنه البحث من نتائج، وما تقدمت به الباحثة من توصيات، وفيما يلي تعرض الباحثة لبعض الدراسات التي ترى إمكانية إجرائها في المستقبل:

- ١- العلاقة بين المهارات الحياتية ومفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي.
- ٢- فعالية برنامج تدريبي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتنمية المهارات الاستقلالية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد.
- ٣- فعالية التدريب على مهارات الحياة اليومية الشخصية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد.

المراجع

- إبراهيم عبدالله الزريقات (٢٠٢٠). **التدخلات الفعالة لاضطراب طيف التوحد**. عمان: دار الفكر.
- إحسان غديفان السريع (٢٠١٦). مستوى المهارات الاستقلالية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد المدمجين في المدارس في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية من وجهة نظر المعلمين في الأردن. **مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر**، ٣٥(٢)، ٢٩٩-٣٢٢.
- أسامة عبدالقادر (٢٠٠٩). العوامل الأسرية المرتبطة في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مهارات السلوك الاستقلالي. **رسالة ماجستير**، كلية خدمة اجتماعية، جامعة حلوان.
- إلهامي عبدالعزيز إمام (١٩٩٩). **سيكولوجية الفئات الخاصة دراسة حالة ذاتوية**، القاهرة: دار الكتب، ط ١.

فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد

- أمل علي (٢٠١١). فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات الحياتية لدى عينة من الأطفال التوحديين. *رسالة ماجستير*، كلية رياض الأطفال، جامعة الإسكندرية.
- أنور محمد الشرقاوي (١٩٨٦). *إنحراف الأحداث*. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- إيرلي بالثازار (١٩٩٩). *تدريب المتخلفين في المنزل والمدرسة دليل الوالدين والمدرسين ومدربي الأطفال بالمنزل*. ط١، ترجمة عبد الرقيب أحمد البحيري، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- إيمان عبيد (٢٠١٦). الألعاب المائية كمدخل لتحسين مهارات العناية بالذات لدى الطفل التوحد. *مجلة البحث العلمي في التربية*، جامعة القدس.
- جمال محمد الخطيب (٢٠٠٣). *تعديل السلوك الإنساني*. عمان: دار حنين.
- جودت عبد الهادي (٢٠٠٧). *نظريات التعلم*. عمان: دار الثقافة.
- جورج أم غاردا (١٩٨٦). *نظريات التعلم دراسة مقارنة*. ترجمة: علي حسين حجاج، الكويت: مجلة عالم المعرفة.
- حسن مصطفى عبدالمعطي (٢٠٠١). *الاضطرابات النفسية في الطفولة المبكرة والمراهقة "الأسباب - التشخيص - العلاج"*، القاهرة: مكتبة القاهرة، ط٤.
- حسين أبو رياش، وزهرية عبدالحق (٢٠٠٧). *علم النفس التربوي للطالب الجامعي والمعلم الممارس*. عمان: دار الميسرة.
- خالد شريف عياش (٢٠١٥). فعالية برنامج تدريبي سلوكي يستند إلى نظام تبادل الصور (بيكس) لتنمية مهارات التواصل لدى أطفال التوحد، *مجلة جامعة القدس الفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية*، ١٠ (٣)، ١٥٨ - ١٨٦.
- رائد خليل العبادي (٢٠٠٦). *التوحد*. عمان: مكتبة المجتمع العربي.
- ربيع شكري سلامه (٢٠٠٥). *التوحد - اللغز الذي حير العلماء والأطباء*. القاهرة: دار النهار.
- رونالدكولا روسو، كولين أورورك (٢٠٠٣). *تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة*. المجلد ١، (ترجمة أحمد الشامي، أيمن كامل، عادل دمرdash، على عبد العزيز، مراجعة: محمد عناني)، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر.
- ريم إبراهيم الشرقاوي (٢٠١٥). فعالية برنامج تدخل مبكر في تنمية التأزر البصري الحركي وتحسين مهارات رعاية الذات لدى الأطفال التوحديين. *رسالة ماجستير*، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- ريم أحمد إبراهيم (٢٠١٩). دور الألعاب في تنمية العناية بالذات لذوي الاحتياجات الخاصة، *مجلة بحوث التربية الشاملة*، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق، ٢، ٦٩ - ١١٠.
- سميرة عبداللطيف السعد (٢٠٠١). *معاناتي والتوحد (أسبابه - صفاته - علاجه - أفضل طرق التعليم)*. الكويت: منشورات ذات السلاسل.

سهى بدوي منصور (٢٠١٦). تقبل وتسامح الوالدين وتنمية مهارات رعاية الذات لدى الطفل ذي اضطراب طيف التوحد: دراسة تحليلية ميدانية، مجلة الإرشاد النفسي، جامعة عين شمس، ٤٨، ١٤٧-١٩١.
سوسن شاكر الجليبي (٢٠٠٥). **التوحد الطفولي "أسبابه - خصائصه - تشخيصه - علاجه"**. دمشق: مؤسسة علاء الدين.

صابرة عبدالناصر خليل (٢٠٢٢). التوحد: التشخيص والعلاج في ضوء النظريات. **المجلة العربية لعلوم الإعاقة والموهبة**، ٢٠، ٨٥ - ٩٩.

عادل عبدالله محمد (٢٠١١). **مدخل إلى اضطراب التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية**. القاهرة: دار الرشد للطبع والنشر والتوزيع.

عادل عبدالله محمد (٢٠١٣). **تحليل السلوك التطبيقي**. الرياض: دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع.
عادل عبدالله محمد (٢٠١٤). **مدخل إلى اضطراب التوحد: النظرية والتشخيص وأساليب الرعاية**، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ط ١.

عادل عبدالله محمد (٢٠١٩). **أساليب تشخيص وتقييم اضطراب التوحد**. الرياض: دار الزهراء.
عادل عبدالله محمد (٢٠٢١ب). **تعليم الأطفال ذوي اضطراب التوحد**. الاسكندرية: مؤسسة حورس الدولية.
عادل عبدالله محمد (٢٠٢٥). **بطارية اختبارات لبعض مهارات الحياة اليومية التقليدية والرقمية للأطفال والمراهقين العاديين وذوي الإعاقات**. الاسكندرية: مؤسسة حورس الدولية.

عبدالرحمن سيد سليمان (٢٠٠٤). **اضطراب التوحد**. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ط ٣.
عبدالعزیز الشخص (٢٠١٣). **مقياس تشخيص اضطراب التوحد للأطفال**. القاهرة: مكتبة الأنجلو.
عبدہ سعید الصنعاني (٢٠١٤). فاعلية برنامج تدريبي للمربيات في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى الأطفال الذاتيين (التوحيدين). **رسالة دكتوراه**، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.
عثمان لبیب فراج (١٩٩٦). **إعاقة التوحد (التشخيص، والكشف المبكر)**، **مجلة الحياة الطبيعية حق للمعوق**، القاهرة: اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.

عثمان لبیب فراج (٢٠١٢). **الإعاقات الذهنية في مرحلة الطفولة "تعريفها - تصنيفها - أعراضها - تشخيصها - أسبابها - التدخل العلاجي"**، القاهرة: المجلس القومي للطفولة والتنمية.

عزة جمال (٢٠١٧). فاعلية برنامج هيلب لتنمية مهارات التواصل والعناية بالذات لدى الأطفال الذاتيين. **رسالة ماجستير**، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة القاهرة.

علا عبد الباقي (٢٠١١). **اضطراب الذاتوية**. القاهرة: عالم الكتب.
عواطف الشمري (٢٠٠٨). فاعلية استخدام إجرائي المساعدة المتناقصة تدريجيًا، والتأخير الزمني الثابت في التدريب على بعض المهارات الاستقلالية للفنيات ذوات التخلف العقلي المتوسط والشديد. **رسالة ماجستير**، كلية التربية، جامعة الملك سعود.

فعالية برنامج إرشادي قائم على مفاهيم نظرية التعلم الاجتماعي لتحسين مهارات التغذية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد

غادة قطب (٢٠١٢). فعالية برنامج تدريبي لتنمية المهارات الاجتماعية، وتعديل السلوكيات غير التكيفية للأطفال التوحديين. *رسالة ماجستير*، كلية التربية، جامعة بني سويف.

فاروق فارح الروسان، صالح عبدالله هارون، رويدا محمد العطوي (٢٠١٥). *مناهج تدريس مهارات الحياة اليومية لذوي الاحتياجات الخاصة*. عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.

كريم منصور عسران (٢٠١٩). فعالية برنامج تدريبي في تنمية بعض مهارات العناية بالذات لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد. *مجلة التربية الخاصة*، جامعة الزقازيق، ٨(٢٩)، ٥١ - ١٠٧.

كوثر عبدربه عواد (٢٠١٢). أثر برنامج التدخل (TEACCH) في تنمية الحياة اليومية لدى عينة من أطفال التوحد في الأردن. جامعة الدكتور يحيى فارس، *مجلة الطفولة والتربية*، ٩(٤)، ٣٠ - ٤٣.

لمياء عبدالحميد بيومي (٢٠٠٨). فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات العناية بالذات لدى الأطفال التوحديين، *رسالة دكتوراه*، كلية التربية، جامعة قناة السويس.

ماجد السيد عماره (٢٠٠٥). *إعاقة التوحد بين التشخيص والتشخيص الفارق*، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.

مجدي فتحي غزال (٢٠٠٧). فاعلية برنامج تدريبي في تنمية المهارات الاجتماعية لدى عينة من الأطفال التوحديين في مدينة عمان، *رسالة ماجستير*، الجامعة الأردنية، عمان.

محمد موسى، وزينب شقير، وعادل عبدالله (٢٠٠٦). فعالية برنامج إرشادي تدريبي لأمهات الأطفال التوحديين لتنمية بعض مهارات السلوك الاستقلالي لهؤلاء الأطفال باستخدام جداول النشاط المصورة. *مجلة رعاية وتنمية الطفولة*، ٤(٤)، ٤٧٠ - ٤٨٣.

مصطفى عصام النمر (٢٠١٥). *الأسرة وأطفالها ذوي الاحتياجات الخاصة*. عمان: إلسازوري للنشر والتوزيع، ط٢.

Alexa, M. (2018). *Understanding the origins of autism and associated sensory processing disorders*. Retrieved March 7, 2018 from www.dealwithautism.com/news/Understanding-the-origins-of-autism-and-associated-sensory-processing-disorders.

Asta, Lisa & Persico, Antonio, M. (2022). Differential predictors of response to early start Denver model vs, early intensive behavioral intervention in young children with autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. *Brain Sciences*, 12(11), 149-156.

Biklen, D. (2002). Communication unbound: Autism and praxis, Harvard Educational Review, (60), 10-20.

Carr, E & Kemp, A. (2013). Acquisition of sign language by autistic children: Spontaneity and generalization effects. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 16(3), 297-316.

Center for Disease Control and Prevention. (2011). the intentionality model and language acquisition: engagement, effort and the essential tension in

- development. *Monographs of the society for research in child development*, 66, 1-104.
- Davis, B. (2002). Dangerous encounters: Avoiding situation with autism, UK: Jessica Kingsly Publishers.
- Gal, E. C. (2007). Sensory processing disorders in children with autism, nature, assessment, and intervention. Growing up with autism, working. New yotk us, Guilford press, (15), 95-123.
- Joseph, Liji & Delariarte, Clarissa F. (2022). Prevalence of depression, anxiety and stress among mothers of children with autism spectrum disorder in India during COVID-19 pandemic. *India Journal of Health & Wellbeing*, 13(3), 301-306.
- Manner, M., Shaw, K., & Baio, J. (2020). Prevalence of autism spectrum disorder among children with among children aged 8 years- autism and development disabilities in receptive with expressive language abilities. *International journal of language communication disorders*, 54(6), 681-690.
- Marzi, Claudia; Narzisi, Antonio; Miline, Annarita; Masri, Gabriele; Pirrelli, Vito. (2022). Reading behaviors through patterns of finger-tracking in Italian children with autism spectrum disorder. *Brain Sciences*, 12(10), 1316- 1323.
- National Society for Autistic Children. (2012). Autism Facts and history. <https://www.autism.Org-us/about/what-is/myths-facts-stats.aspx>.
- Wolf, S. (2005). Psychiatric Disorders of Childhood in Kendell, R. E. and 2eally, A. K. (Eds) Companion to Psychiatric studies, London disciplines, Oxford: Pergamon press.
- Wright, J. (2017). The Real Reason Autism Rates Are Up in the U.S: A hard look at whether the rise comes from more awareness, better diagnosis-or something else. Scientific American. Spectrum on March 3, 2017.